Santé
Université de Paris

Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

UE Sciences Humaines et Sociales

Définitions et histoire de l'éthique et de la bioéthique

- *Responsables de l'UE : C. Lefève, S. Lellinger, M.-F. Mamzer*
- *Enseignante : C. Lefève, Pr de philosophie de la médecine et du soin (Département Histoire et Philosophie des Sciences/UMR SPHERE)*

Année universitaire 2026-27

ATTENTION

- En raison d'un problème technique informatique, le cours a démarré avec 10 minutes de retard.
- Par conséquent, sont à apprendre seulement les diapositives 4 à 34, puis la diapositive 36 et la diapositive 38.

Introduction

1. Nécessité de l'éthique médicale
2. Distinctions

I. L'éthique médicale hippocratique

II. La constitution d'une éthique de l'expérimentation humaine (19e-20e siècles)

1. L'essor de l'expérimentation humaine
2. L'émergence de la notion de consentement
3. Le Code de Nuremberg

III. L'émergence et l'évolution de la bioéthique (à partir des années 1960)

1. Le mot « bioéthique »
2. Le contexte d'émergence de la bioéthique aux Etats-Unis et en France
3. L'institutionnalisation de la bioéthique
4. Les lois de bioéthique en France : quelques évolutions

Conclusion

Introduction

1. Nécessité de l'éthique médicale :

a. Définition de l'éthique : **réflexion rationnelle sur les principes, valeurs et règles de l'action humaine**

- Une partie, voire le but de la philosophie.

b. Définition et objectifs de l'éthique médicale :

Identifier et analyser les principes, les valeurs et les conflits de valeurs qui sont en jeu dans

- ✓ les situations de soin,
- ✓ la recherche
- ✓ et les politiques de santé publique.

Afin que l'ensemble des acteurs **prennent des décisions éclairées**, dont ils cernent les enjeux moraux et dont ils assument **la responsabilité**.

c. Les questions d'éthique médicale ne concernent pas seulement les progrès des **sciences de la vie et des techniques en médecine et leurs applications aux soins des patients** (par ex. réanimation, transplantation d'organes, assistance médicale à la procréation, thérapies géniques, usage des données, de l'intelligence artificielle), mais aussi **toutes les pratiques cliniques (au lit du malade), y compris celles qui n'impliquent pas d'innovations scientifiques ou techniques.**

Par ex.

- annoncer un diagnostic de maladie grave,
- assister un couple infertile dans un projet de grossesse,
- diagnostiquer la maladie ou la malformation d'un fœtus,
- décider de poursuivre ou non la réanimation d'un très grand prématuré,
- accompagner une personne malade chronique et décider avec elle de ses traitements,
- décider de l'hospitalisation d'une personne souffrant de troubles mentaux,
- accompagner une personne en fin de vie et son entourage,

=> tous ces actes médicaux comportent des enjeux éthiques. En particulier celui de savoir comment agir pour le bien d'autrui, de manière bienfaisante, tout en respectant son autonomie, sa propre vision du bien, ses valeurs concernant sa propre existence, son propre corps (– y compris quand elle ne peut pas ou plus exprimer sa volonté) ?

d. Les questions éthiques sont indissociables de la pratique médicale, notamment pour 3 raisons fondamentales :

- ✓ **La médecine possède une finalité, un but *éthique*.**

  Elle se définit par ***le souci d'autrui*** **(le soin)** : elle vise à soulager ses souffrances, à répondre à ses besoins, non seulement à traiter sa maladie mais à prendre soin de lui, à l'accompagner dans sa vie avec la maladie.

- ✓ La médecine est une pratique sociale et relationnelle qui implique des acteurs divers, qui possèdent **leurs valeurs morales** propres dans des institutions et une société elles-mêmes porteuses de valeurs. **Ces valeurs peuvent entrer en *conflit*.**

- ✓ Les décisions médicales impliquent souvent de choisir entre des options qui toutes présentent des bénéfices et des risques, ainsi qu'une large part d'incertitude. **Ces décisions se situent dans le domaine du *préférable*, ici et maintenant pour tel patient et dans telle situation, et non dans le domaine du bien qui pourrait être déterminé dans l'absolu et de manière définitive.**

=> C'est pourquoi les acteurs en santé doivent être au clair avec leurs principes et valeurs morales et celles d'autrui, capables de les expliciter, d'en discuter ensemble pour décider ensemble – y compris avec les personnes malades et leur entourage.

L'éthique n'est pas extérieure à la médecine, elle n'en est pas un *supplément*. La médecine ne peut en être séparée sans perdre son sens.

Cependant, la médecine comporte le **risque** d'échouer à être éthique, à être respectueuse de la personne humaine.

Le soin n'est pas une partie de la médecine (soins infirmiers, soins palliatifs, etc.) mais l'essence même de la médecine.

Il est une réponse **technique** aux besoins, physiques, psychiques et sociaux, d'une personne qui requiert **des savoirs et des compétences scientifiques et techniques,**

MAIS AUSSI une **relation morale** qui requiert **le souci de la personne malade, la sollicitude envers elle, l'attention et la compréhension de son expérience vécue, l'adaptation à ses besoins globaux (biologiques mais aussi psychologiques et sociaux) qui sont toujours singuliers.**

Cependant, la médecine comporte le risque d'échouer à être éthique, à être respectueuse de la personne humaine.

- ne pas assez prendre en compte l'expérience vécue et singulière de la personne malade.

- négliger sa douleur et sa souffrance,

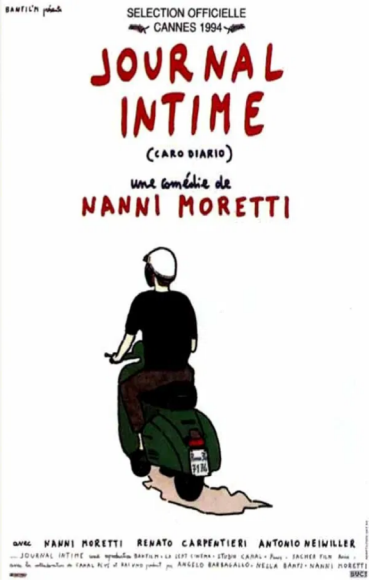
- ne pas respecter ses valeurs et sa volonté par ex. en décidant à sa place,

- ne pas répondre à ses questions (parce qu'elles sont mal formulées ou parce qu'elles angoissent le médecin qui ne sait pas y répondre),

- la rendre responsable de sa maladie (à cause de ses comportements),

- ne pas lui offrir des soins équitables, en pratiquant des discriminations sociales soit à cause de préjugés sociaux ou racistes, soit en n'étant pas assez vigilant aux inégalités sociales de santé et d'accès aux soins, etc.









2. Distinctions :

a. Ethique et morale

- Les termes **éthique** et **morale** ont la même signification. Le grec *éthos* et le latin *mora* signifient la conduite de la vie, les mœurs, les règles de comportement.
- On peut définir la « morale » comme un système constitué, établi et plus ou moins interrogé de principes, de règles et de valeurs.
- « L'éthique » renvoie à la réflexion rationnelle et critique sur la morale.

b. Déontologie : ensemble des devoirs d'une profession. *Deon* : devoir

- Ex. **Code de déontologie médicale** adopté par le Conseil de l'Ordre des médecins

c. Droit : Les **lois** sont les règles que se donne une société en vue d'harmoniser les relations et les intérêts, et de régler les conflits

L'éthique réfléchit de manière critique sur la déontologie et le droit, qu'elle peut contribuer à transformer (ex. révision régulière des lois de bioéthique).

3. Diversité des pratiques, lieux et acteurs de l'éthique

L'éthique médicale recouvre une grande diversité de pratiques et de contextes :

- des **recherches théoriques et empiriques (fondées sur l'étude des expériences et des terrains médicaux)** qui donnent lieu à des publications dans des revues d'éthique ou de médecine : *Journal of Medical Ethics, Hastings Center Report*, etc.
- des **pratiques quotidiennes des professionnels de santé** : dans les staffs de services hospitaliers, dans des consultations d'éthique par ex. en médecine génétique, dans les comités d'éthique de la recherche, dans des comités d'éthique clinique
- des **débats publics** et **citoyens essentiels à la démocratie** auxquels participent professionnels de santé, patients, juristes, philosophes, politiques, etc.
- **L'éthique n'est pas réservée aux médecins ni à des experts ou des sages (appelés « éthiciens ») : elle est l'affaire de chacun et de chacune,** de tous les individus doués d'une conscience morale et soucieux des questions de santé et de soin (au-delà des seuls professionnels et usagers du système de santé).

I. L'éthique médicale hippocratique

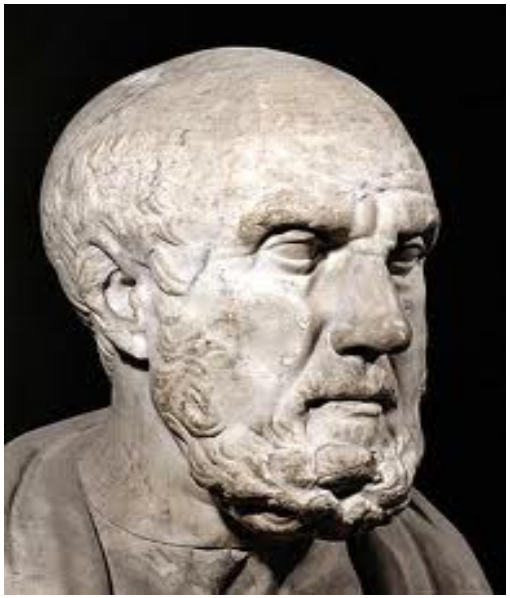
Hippocrate (Vème siècle avant J. -C.) considéré comme le fondateur de la médecine occidentale

- **Corpus hippocratique**

- Serment d'Hippocrate

- Principes et règles concernant ce que le médecin peut, doit ou ne doit pas faire :

- rechercher le bien du patient
- ne pas nuire au patient : *primum non nocere*
- respecter la discrétion, prémice du secret médical
- ne pas avoir de relations sexuelles avec le patient
- ne pas donner la mort à travers l'empoisonnement, l'avortement ou l'euthanasie.
- Dans d'autres textes hippocratiques, refus de distinguer entre riches et pauvres, concitoyens et étrangers, : « S'il y a lieu de secourir un homme étranger et pauvre, c'est surtout le cas d'intervenir ; car là où est l'amour des hommes est aussi l'amour de l'art ».



- **Ces devoirs du médecin constituent des règles déontologiques : il faut les respecter et les enseigner pour faire partie de la profession médicale. Elles protègent autant le malade mais aussi le médecin de l'accusation de charlatanisme.**

A LIRE pour retenir les notions principales

Texte n°1 :

Serment d'Hippocrate :

« Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivants : Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir, et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils, à ceux de mes maîtres, et aux disciples liés par un engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion ; semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je laisserai aux gens qui s'en occupent. Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Qui que je voie ou entende dans la société pendant l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas. Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes ; si je le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire ! »

HIPPOCRATE, *De l'Art médical*, trad. E. Littré, Livre de Poche, 1994, p. 82-83.

II. La constitution d'une éthique de l'expérimentation humaine (19-20e siècles)

1. L'essor de l'expérimentation humaine (19e siècle)

- dès le début du 19e s., hôpital : lieu de recherches et d'enseignement autant que de soin

- 2e moitié 19e s. : essor de la microbiologie, de la bactériologie. Essor de l'expérimentation humaine.

- Expérimentation : production artificielle par un chercheur de phénomènes en vue de leur observation précise, complète et méthodique et de connaître leurs causes.

- Expérimentation pathologique : expérimentation consistant à provoquer artificiellement une maladie chez un individu à des fins de recherche.



- **La question éthique que pose l'expérimentation portant sur des sujets humains est celle de l'articulation entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, le collectif et l'individuel** : l'expérimentation humaine vise à augmenter les connaissances qui profiteront à tous ou à beaucoup de personnes malades, mais elle prend pour objets des sujets qui, eux, n'en tirent pas toujours un bénéfice direct.
- L'expérimentation humaine pose donc le problème de **l'instrumentalisation** des sujets qui se prêtent à des expériences ne présentant pas de bénéfices pour eux.
- **Il faut donc que l'expérimentation présente un rapport bénéfices/risques éthiquement acceptable.**

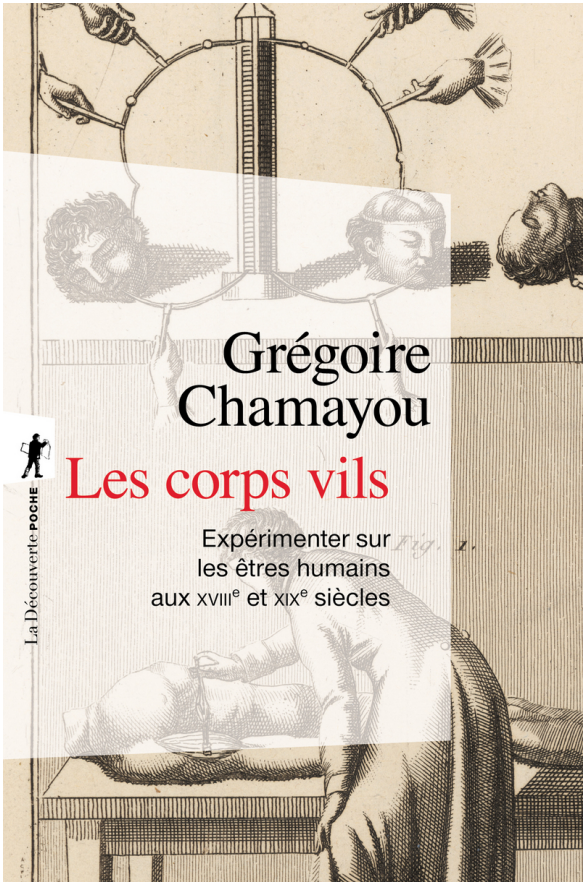
Université Paris Cité

Jusqu'au début du 20e siècle, **les sujets de l'expérimentation appartenaient souvent à des populations socialement dominées, assujetties, contrôlées :**

- des malades hospitalisés (**texte n°2**), déments ou incurables, donc **dans une relation de vulnérabilité due à la maladie et de dépendance aux médecins et à l'institution hospitalière**
- des enfants, des orphelins,
- des pauvres,
- des prostituées,
- des prisonniers,
- des soldats,
- des esclaves noirs aux Etats-Unis, cf. **texte n°3**
- des « indigènes » dans les colonies, cf. **texte n°4.**

Ces expérimentations s'effectuent sans le consentement préalable, libre et éclairé, des sujets.

Le médecin qui conduit l'expérimentation évalue lui-même le bien du malade et décide de l'intérêt et de la légitimité de l'expérimentation.



Les textes suivants de n° 2 à n°7 doivent impérativement être lus et les principales notions doivent être connues car ils illustrent le cours.

L'hôpital au 19e siècle comme lieu de mise à disposition des corps pour l'observation et l'expérimentation :

Lire le texte n° 2 d'histoire de la médecine de **CHAMAYOU G. , *Les corps vils*. *Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, La Découverte, 2008, p. 169-172.**

« A l'origine, l'hôpital ne désigne pas exclusivement une institution destinée à accueillir et soigner des malades, mais le lieu d'exercice de l'hospitalité, lieu d'accueil et d'asile, d'inspiration religieuse. L'hôpital héberge des indigents, dont certains seulement sont malades.

L'institution hospitalière est (…) devenue en France, avec l'édit de 1656 créant l'Hôpital général, le fer de lance d'une politique centralisée de répression de la mendicité, qui en fait le lieu de réclusion des indigents, sains ou malades, dans une logique de moralisation des pauvres autant que d'assistance.

Plus tard s'opère la spécialisation médicale de ces établissements, dans un processus qui voit l'hôpital devenir une clinique. C'est au cours du XVIIIe s. que l'hôpital devient une institution proprement médicale. (…)

Pour les médecins, contre la charité désintéressé, assimilée à une sorte de gaspillage, il s'agit (…) de rendre les hôpitaux enfin *utiles.* (…) L'anglais Aikin met ainsi en avant l'utilité des hôpitaux, « en tant qu'ils contribuent à étendre les bienfaits de l'art de guérir en procurant des avantages aux étudiants, et en fournissant à la pratiques des occasions d'acquérir l'expérience. » (John Aikin*, Observations sur les hôpitaux*, Crapart et Briand, Paris, 1777, p. 92.) La médecine est une science pratique. Pour un étudiant, il n'y a que l'hôpital qui puisse l'en instruire, car c'est le lieu où peuvent se pratiquer les indispensables essais. Pour Aikin, « les malades d'hôpital sont, sous plusieurs rapports, les sujets les plus propres pour un cours expérimental ; l'inspection assidue des personnes (…), leur soumission aux ordonnances, leur assujettissement aux règles strictes de la diète et du régime, sont des avantages qu'on ne peut se promettre en un degré égal dans la pratique privée, ni parmi les riches, ni parmi les pauvres. (…) Le ménagement qu'exige la réputation d'un praticien, sur lequel le public a les yeux, et dont chaque pas est exposé aux remarques des spectateurs sévères et pleins de vanité, n'est que trop propre à rétrécir ses vues et à l'intimider dans sa pratique ; (…) dans un hôpital, il est à l'abri d'une pareille entrave, et son génie peut s'exercer d'une manière nouvelle pour le secours de son malade (…). »

CHAMAYOU G. , ***Les corps vils*****.** ***Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*****, Paris, La Découverte, 2008, p.** 104-105)

On trouve de multiples témoignages en ce sens durant toute la période. Un médecin français fait encore au début du XIXe siècle le même constat concernant les avantages que présentent les patients de l'hôpital pour l'expérimentateur : « Pour avancer qu'une méthode de traitement est avantageuse, elle doit être répétée un grand nombre de fois, disons-nous. Le médecin l'appliquera dans sa pratique, soit en ville, soit dans les hôpitaux. (…) Le médecin qui exerce dans les hôpitaux a d'immenses avantages. Beaucoup de malades lui passent sous les yeux ; ils sont à *sa merci* en quelque sorte ; il les suit depuis le commencement jusqu'à la fin ; et, si ses efforts ont été infructueux, l'autopsie, souvent impossible en ville, lui révèle qu'il a erré, pourquoi la nature a rendu ses tentatives vaines. » (P. G. JOUSSET, *De l'expérimentation thérapeutique et de l'appréciation des agents de la matière médicale*, Thèse de médecine, n°183, Paris, 1829, p. 10). »

CHAMAYOU G. , *Les corps vils*. *Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, La Découverte, 2008, p. 169-172.

Expérimentation humaine et esclavagisme aux Etats-Unis au 19e siècle

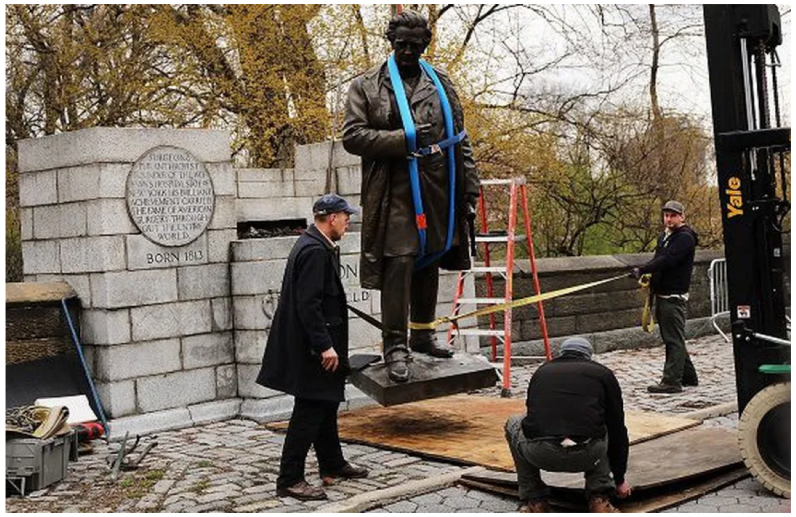
Lire le texte n° 3 d'histoire de la médecine de **CHAMAYOU G. , *Les corps vils*. *Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, La Découverte, 2008, p. 346-347.**

« Les travaux de Todd L Savitt (Todd L. SAVITT, « The Use of Blacks for Medical Experimentation and Demonstration in the Old South », *Journal of Southern History*, 48, 1982, p. 331-348) montrent (…) que les esclaves noirs ont continué, en dépit du racisme scientifique, au moins jusqu'à la guerre de Sécession au sud des Etats-Unis, à former, avec les pauvres en général, une des principales sources d'approvisionnement en sujets d'expérience ou d'enseignement anatomique. La raison qu'il en donne est d'ordre pragmatique : « Les noirs étaient considérés comme plus disponibles et plus accessibles dans cette société placée sous domination blanche : ils étaient rendus physiquement visibles par leur couleur de peau, mais socialement invisibles en raison de leur statut d'esclaves. » Savitt rapporte des cas de dissection *post mortem* effectués systématiquement sur des Noirs, ainsi que des cas d'essais thérapeutiques. Il cite des exemples de médecins achetant des esclaves à des fins d'expérimentation, ou publiant dans la presse des annonces à destination des maîtres, leur proposant contre rémunération d'utiliser des esclaves atteints de certaines pathologies pour des essais thérapeutiques.

Les expériences les plus célèbres furent menées par le docteur James Marion Sims, « père fondateur » de la gynécologie moderne, qui mit au point ses techniques chirurgicales pour le traitement de la fistule vésico-vaginale (…) sur des femmes esclaves lui appartenant ou bien louées à leurs maîtres, de 1845 à 1849. Ce n'est qu'une fois sa technique opératoire rodée sur les femmes esclaves qu'il consentit à opérer des femmes blanches. (…) La pratique de l'expérimentation apparaît ainsi dans un *continuum* de *l'exploitation,* au même titre que le travail forcé (…).

Les esclaves sont employés à la place des Blancs et avant eux, pour endosser à leur place les risques ou les désagréments de l'expérience. (…) Cela supposait que l'on pense les corps des sujets blancs et des sujets noirs dans une certaine mesure comme substituables, interchangeables. Savitt note à ce propos : « (…) On supposait généralement que les informations obtenues par l'observation des corps des Nègres étaient applicables aux Caucasiens. En dépit de la rhétorique politique alors en vigueur dans le Sud, (…) les Nègres ne semblaient pas différer suffisamment des Caucasiens pour les exclure de leur usage intensif dans l'enseignement et la recherche médicale dans les Etats du Sud. » »

CHAMAYOU G. , *Les corps vils*. *Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, La Découverte, 2008, p. 346-347.



Statue de J. M. Sims déboulonnée en 2018 à Central Park, New-York

Expérimentation humaine et colonisation au 20e siècle

Lire le texte n° 4 d'histoire de la médecine de **CHAMAYOU G. , *Les corps vils*. *Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, La Découverte, 2008, p. 376-378.**

« La codification méthodologique de la bactériologie expérimentale rend nécessaire l'expérimentation pathologique sur l'homme. Un réquisit de méthode qui se heurte – en métropole, mais pas forcément dans les colonies – à des réticences morales et à des interdits juridiques. Au moment même où, en Europe, certaines expérimentations font scandale et donnent lieu à des procès retentissants, aux colonies les médecins peuvent expérimenter sans crainte de poursuites.

A titre d'exemple, en 1908, les docteurs Yersin et Vassal, en Indochine, observent des symptômes étranges sur des coolies tonkinois, ouvriers « débarqués de Nhatrang pour servir sur les chantiers de construction de la voie ferrée. » (Alexandre YERSIN, Joseph VASSAL, « Une maladie rappelant le typhus exanthématique observée en Indochine », *Bulletin de la Société de pathologie exotique*, I, 1908, p. 156.) Ils pensent avoir affaire à une maladie inconnue, qui leur rappelle le typhus exanthémique. Pour en avoir le cœur net, ils engagent des recherches conformes aux réquisits méthodologiques de la bactériologie expérimentale : « Après avoir vainement tenté de reproduire la maladie qui nous occupe sur les animaux de laboratoire (rats, cobayes, lapins), nous avons pensé qu'il serait d'un grand intérêt scientifique d'être renseigné au plus vite par des expériences sur l'homme. »

Les médecins s'y croient autorisés par la bénignité relative de la maladie et les précédents des expérimentations sur la fièvre jaune : « Nguyen Van Ky, provenant du village de Van-Khâu (…) est admis dans nos salles de l'hôpital indigène de Nhatrang pour ulcère des jambes (…). Cet homme se soumet volontairement à une inoculation dont les suites probables ne lui sont pas inconnues. – Le 1er juin, Nguyen Van Ky est inoculé sous la peau du bras avec 0 gr. 50 du sang puisé dans une des veines du bras de Tran Luan, qui est au second jour de la maladie (…) le sujet fut pris d'une fièvre intense qui persista 11 jours (…) les symptômes de la maladie naturelle ont été reproduits avec la plus grande netteté. »

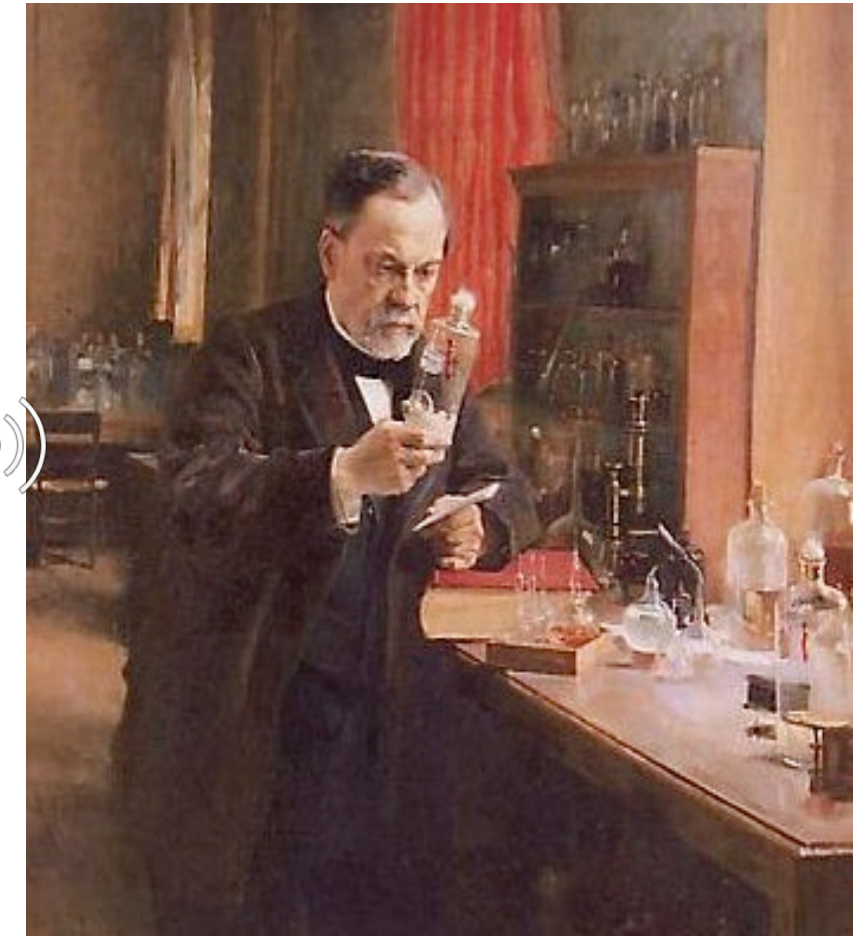
Sous le régime de la souveraineté coloniale, l'indigène est un sujet sur lequel tend à s'exercer un *dominium* absolu. Achille Mbembe caractérise le gouvernement colonial par la modalité fondamentale du commandement : une souveraineté inconditionnelle, fondée sur la violence primordiale de la conquête, légitimée par un racisme colonial, reproduite et réitérée de façon permanente dans les situations les plus ordinaires. » (Achille MBEMBE, *De la Postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine*, Karthala, Paris, 2000, p. 44.)

CHAMAYOU G. , *Les corps vils*. *Expérimenter sur les êtres humains aux XVIIIe et XIXe siècles*, Paris, La Découverte, 2008, p. 376-378.

Texte n° 5

Louis Pasteur demande en 1884 à l'Empereur du Brésil, qui refusera, de mener des expérimentations sur la rage et le choléra sur des condamnés à mort.

« Ni les docteurs Straus et Roux, ni le Dr Koch n'ont réussi à donner le choléra à des animaux et dès lors une grande incertitude règne au sujet du bacille auquel le Dr Koch rapporte la cause du choléra. On devrait pouvoir essayer de communiquer le choléra à des condamnés à mort en leur faisant ingérer des cultures de bacille. Dès que la maladie serait déclarée, on éprouverait des remèdes qui sont conseillés comme étant les plus efficaces en apparence. J'attache tant d'importance à ces mesures que si Votre Majesté partageait mes vues, malgré mon âge et mon état de santé, je me rendrais volontiers à Rio de Janeiro, pour me livrer à de telles études de prophylaxie de la rage ou de la contagion du choléra et des remèdes à lui appliquer. »



2. L'émergence de la notion de consentement fin 19e - début 20é s.

- **En 1900, en Allemagne, 1ère loi sur l'expérimentation humaine : une expérimentation non thérapeutique est interdite si elle n'est pas précédée d'un consentement explicite et d'une information préalable.**
- **1931** : promulgation des ***Directives concernant les traitements médicaux nouveaux et l'expérimentation scientifique sur l'être humain* (*Richtlinien*).** Principes centraux : l'autonomie du patient, la notion de consentement éclairé et la possibilité pour le sujet de l'expérimentation d'interrompre l'expérience à tout moment. Ce texte condamne aussi les expériences sur les enfants et les mourants.

3. Le Code de Nuremberg (1947)

Les expérimentations criminelles nazies jugées au Procès de Nuremberg (1939-1945) :

- Motifs « médicaux » : recherche de traitements de maladies infectieuses (paludisme, typhus, tuberculose, mise au point d'antibiotiques, etc.)
- Motifs militaires : tests de survie en haute altitude, en hypothermie, etc.
- Motifs idéologiques : « recherches » sur le caractère racial du sang et sur des procédés de stérilisation en vue de la stérilisation massive des Juifs et des Tsiganes.

« Recherches » menées sur des sujets détenus (camps de concentration), non consentants, considérés comme du matériel biologique, dénués de droits et souvent mis à mort.

Processus en grande partie caché, mais connu de tous les médecins et chercheurs allemands de l'époque et appuyé par le régime, l'université, l'industrie, notamment pharmaceutique, et qui a fait des milliers de victimes.

Les expérimentations menées par les médecins nazis : l'exemple des expérimentations en vue de la stérilisation de masse texte n°6

Bruno HALIOUA, *Le procès des médecins de Nüremberg*, Vuibert, 2007, p. 105-107.

« Au cours du procès (de Nuremberg), 8 accusés (Karl Brandt, Karl Gebhardt, Rudolf Brandt, Joachim Mrugowsky, Helmut Poppendich, Viktor Brack, Adolf Pokorny et Herta Oberheuser) doivent répondre de l'accusation d'avoir participé aux expériences de stérilisation réalisées de mars 1941 à janvier 1945 à Auschwitz et Ravensbrück, en vue de la mise en place d'un procédé efficace pour stériliser des millions de personnes. Le point de départ de cette expérimentation est un courrier adressé le 28 mars 1941 par Victor Brack, directeur des services centraux de la chancellerie du Führer, au « très honoré Reichsführer » Himmler afin d'attirer son attention sur le fait que « sur 10 millions de Juifs en Europe, il y a au moins 2 à 3 millions d'hommes et de femmes capables de travailler. Considérant les difficultés extraordinaires que le problème du travail soulève, je suis d'avis que ces 2 à 3 millions soient spécialement choisis et préservés. Cela ne peut cependant être réalisé que s'ils sont en même temps rendus incapables de procréer. »

Au terme d'une conférence sur la stérilisation des femmes juives, organisée le 7 ou 8 juillet 1942, à laquelle assistent Heinrich Himmler, Karl Gerhardt, Richard Glücks et Karl Clauberg, il est proposé de réaliser ces expériences dans le cadre d'Auschwitz. Le 10 juillet 1942, Rudolf Brandt adresse un courrier à Karl Clauberg dans lequel il l'informe que le Reichsführer aimerait savoir combien de temps prendrait la stérilisation de 1 000 Juives. Un autre médecin, le docteur Horst Schumann, participe également à des expériences de stérilisation à Auschwitz au moyen de rayons X. Karl Clauberg et Horst Schumann se livrent à une compétition expérimentale sur des femmes à partir de l'automne 1942, dans le bloc 30 du camp des femmes de Birkenau puis dans le bloc 10 du camp d'Auschwitz en mars 1943. La méthodologie de Karl Clauberg consiste à introduire, après un contrôle radiologique de la perméabilité des trompes, toutes les quatre semaines dans l'utérus un produit censé entraîner l'obstruction des trompes. De son côté, Horst Schumann soumet des femmes à une irradiation par des rayons X sur la partie inférieure de l'abdomen puis il réalise dans un second temps une ablation des ovaires. En dehors de la stérilisation des femmes, il réalise également des irradiations des parties génitales sur de jeunes déportés. (…) Les inculpés Karl Gebhardt, Rudolf Brandt et Viktor Brack sont déclarés coupables. »

- **Le Code de Nuremberg sur l'expérimentation humaine (1947) constitue une étape majeure dans l'histoire de l'éthique médicale.**
- **Il affirme la légitimité des expérimentations sur l'homme, tout en posant des limites destinées à protéger les sujets soumis aux expérimentations.**
- **Il affirme la nécessité d'un consentement libre, informé, rétractable sans préjudice à tout moment, comme principe essentiel à toute expérimentation sur l'homme.**



Le **Code de Nuremberg** affirme que

Texte n°7

1) Le consentement libre et éclairé du sujet de l'expérimentation est nécessaire.
La personne doit être libre de décider (elle ne doit pas être soumise à la force, à une contrainte, une fraude, etc.)
Elle doit être informée et comprendre l'expérience : sa nature, ses buts, sa durée, sa méthode, les moyens utilisés, les risques et les conséquences pour sa santé.
2) L'expérience doit avoir des résultats qui ne peuvent être obtenus par d'autres moyens. Elle doit servir le bien public.
3) L'expérience doit être conçue sur la base des résultats obtenus par l'expérimentation animale et en fonction des connaissances scientifiques déjà existantes.
4) L'expérience doit être pratiquée de façon à éviter toute atteinte et souffrance non nécessaire, qu'elles soient mentales ou physiques.
5) L'expérience ne doit pas être tentée lorsqu'il y a une raison de croire qu'elle entraînera la mort ou l'invalidité du sujet.
6) Les risques encourus ne devront jamais excéder l'importance humanitaire du problème que doit résoudre l'expérience.
7) On doit faire en sorte d'écarter du sujet expérimental toute éventualité, si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidité ou la mort.
8) Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes qualifiées.
9) Le sujet doit être libre d'interrompre l'expérience.
10) Le scientifique doit être prêt à interrompre l'expérience en cas de risque probable d'accident, d'invalidité ou de décès du sujet.

III. L'émergence de la bioéthique (à partir des années 1960)

1. Le mot « bioéthique »

- Le terme *bioethics* apparaît en 1971, inventé par un cancérologue américain Rensselaer Van POTTER. Il s'agissait de mettre en oeuvre une alliance entre les sciences biologiques et l'éthique afin de penser les conditions scientifiques et morales de la survie de l'humanité. Ainsi le terme n'est pas relatif à la médecine.
- Grec *bios* : vie et adj. *êthikos* de *êthos* : mœurs.
- **Définition générale à retenir : réflexion pluridisciplinaire portant sur les questions morales et de société posées par le développement des sciences et des techniques dans le champ de la vie et de la santé.**

2. Contexte d'émergence de la bioéthique aux USA et en France

- **Contexte social** : Recul des religions ; pluralisme social (coexistent diverses valeurs morales dans la société) et émergence de la valeur de l'autonomie (les individus revendiquent le droit de décider eux-mêmes et selon leurs propres valeurs de leur existence (profession, mariage, procréation, etc.) ; revendications sociales (luttes pour l'égalité des races et des sexes, la liberté sexuelle, le droit à la contraception, etc.)



Martin Luther King à la Marche sur Washington pour l'emploi et la liberté,28 août 1963



- **Contexte médical et scientifique :**
  - **Révélation de nouveaux scandales de l'expérimentation médicale** : la mise sur le marché de **médicaments toxiques** (thalidomide années 1950) ; expérimentations criminelles (**Tuskegee, Alabama** 1932-1972 : observation à leur insu de la syphilis sur 399 paysans noirs et pauvres, sans leur administrer le traitement pourtant existant (mercure puis pénicilline), dénoncée en 1972 par le NY Times et stoppée. **Rapport Belmont**. Excuses de B. Clinton en 1997)
  - **Critiques de la profession médicale et de la médecine** (paternalisme, déshumanisation d'une médecine devenue hypertechnique)
  - **Innovations dans les pratiques médicales** : **Réanimation**, qui ouvre les questions de l'acharnement thérapeutique et de l'euthanasie volontaire ; définition de la mort comme mort cérébrale et **prélèvements d'organes ;** développement de la **génétique ;**
  - **Critiques de la science** (de ses utilisations militaires, de ses effets sur l'environnement et la biodiversité, émergence de l'écologie)
  - **Questions relatives à la justice sociale, aux inégalités de santé et au partage mondial de la recherche.**

Rapport Belmont, 1979 : « Principes éthiques et lignes de conduite pour la protection des sujets humains de la recherche » (rapport écrit par le Département de la Santé, de l'Education et des Services Sociaux des Etats Unis)

- le principe du **respect des personnes**, fondée sur la conviction éthique que les individus doivent être traités comme des agents autonomes, se réalise dans l'exigence du **consentement informé** préalable à la participation des sujets ;
- le principe de **bienfaisance** se réalise dans l'évaluation de **l'équilibre entre les risques et les bénéfices** pour le sujet et la société, y compris le risque de perte pour la recherche si l'expérimentation n'est pas réalisée ;
- le principe de **justice** se réalise dans la **répartition équitable des chances et des risques** (il faut veiller à ce que seuls des sujets pauvres ne contribuent pas à la mise au point de traitements auxquels seuls des patients riches pourront accéder).

3. L'institutionnalisation de la bioéthique

- **Aux Etats-Unis et au Canada :** Création de centres universitaires et de revues de bioéthique dans les années 1970.
- **En France, émergence plus tardive, liée aux**
  - Débats sur **l'avortement** (loi Veil 1975),
  - puis à **l'assistance médicale à la procréation (1982 naissance d'Amandine)** :
    - don de sperme et anonymat ;
    - FIV et statut de l'embryon (chose ou personne ?) ;
    - recherches sur l'embryon ;
    - diagnostic et dépistage prénatals, sur les critères de l'Interruption Médicale de Grossesse (IMG) et sur le dépistage préimplantatoire.
  - **Création du Comité Consultatif National d'Ethique (1983)** sous l'impulsion du Président de la République F. Mitterrand
- ***Conclusion :***
- Aux Etats-Unis, la bioéthique naît à partir de la remise en cause par la société de l'éthique professionnelle des médecins et est l'objet d'une grande pluridisciplinarité. En France, ce sont les médecins qui, à ses débuts, définissent le champ et les débats de la bioéthique.
- L'éthique médicale devient une partie de la bioéthique. **La bioéthique se préoccupant de problèmes plus larges notamment politiques et sociaux (parenté, justice sociale, environnement, traitement des données de santé, etc).**

4. Les lois de bioéthique en France : quelques évolutions

- En juillet **1994** sont adoptées en France **les 3 premières lois de bioéthique** : elles affirment **la primauté de la personne**, interdisent toute atteinte à sa dignité et garantissent le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Elles prévoient **l'inviolabilité et l'indisponibilité du corps humain**. **Concernant l'assistance médicale à la procréation (AMP)**, la demande doit être formée par un couple formé d'un homme et d'une femme vivants, mariés ou concubins, et en âge de procréer. Elle doit remédier à une infertilité médicalement diagnostiquée, ou éviter la transmission à l'enfant d'une maladie grave. **Concernant le don d'organes,** il doit être gratuit, anonyme et le consentement du donneur est présumé.

LIRE sans apprendre

- **En 2004, la loi de bioéthique** réaffirme la notion de **consentement présumé en matière de don d'organes**, **interdit l'eugénisme, interdit le clonage à visée reproductive ou thérapeutique.** Elle **interdit par principe la recherche sur les embryons, mais il est possible d'obtenir des dérogations de manière limitée, exceptionnelle et temporaire**.
- **En 2013, la loi de bioéthique** passe à une autorisation encadrée des recherches sur l'embryon. Elles pourront être menées à partir **d'embryons surnuméraires conçus dans le cadre d'une procréation médicalement assistée** (FIV), ne faisant plus l'objet d'un projet parental, après information et consentement écrit du couple concerné. La recherche sur ces embryons est limitée à 5 ans et doit avoir pour seul objectif de permettre des progrès thérapeutiques.

- En **2021**, la loi de bioéthique comprend

- **l'élargissement de l'assistance médicale à la procréation aux femmes célibataires et aux couples de femmes;**
- **la possibilité pour les femmes et les hommes de conserver leurs gamètes hors de tout motif médical pour recourir plus tard à une procréation médicalement assistée (PMA)** ;
- **la possibilité pour les enfants conçus par PMA à leur majorité d'accéder à des données non identifiantes du donneur (âge, caractères physiques...) ou à l'identité du donneur. Tout donneur devra consentir à la communication de ces données avant de procéder au don.**

LIRE SANS APPRENDRE

- Le texte permet à la personne qui passe un **test génétique** d'être informée, avec son accord, de la découverte de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale du test dès lors que ces informations lui permettent (ou à sa famille) de bénéficier de mesures de prévention ou de soins.
- Les traitements de données issus de l'intelligence artificielle (IA), lorsqu'ils sont utilisés pour des actes de soins, sont encadrés. **La personne doit être informée de l'utilisation d'un tel traitement algorithmique**.
- La loi élargit le périmètre du **Comité consultatif national d'éthique** aux questions soulevées par les **progrès scientifiques dans d'autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (par exemple développement de l'IA, environnement).** Le CCNE animera tous les ans des débats publics sur des problèmes éthiques.

APPRENDRE

- L'Assemblée nationale a adopté le 15 juillet 2026 **la proposition de loi relative à l'aide à mourir.** Le texte instaure un droit encadré au suicide assisté et à l'euthanasie pour les patients majeurs atteints d'une affection grave et incurable, sa promulgation est suspendue à une décision du Conseil constitutionnel. La loi crée un droit à l'aide à mourir pour les malades majeurs condamnés par une affection grave et qui en ont exprimé la demande, **sous certaines conditions**.
- Ce droit permettra de fournir un produit létal à un malade qui en a fait la demande. Il devra se l'administrer lui-même. Toutefois, s'il en est incapable physiquement, il pourra se le faire administrer par un médecin ou un infirmier. L'auto-administration sera la règle et l'administration par un soignant (l'euthanasie) l'exception.

LIRE SANS APPRENDRE CONCLUSION

- Ethique et bioéthique ne se limitent pas à l'élaboration de lois. Ce sont des groupes de réflexion, des comités d'encadrement de la recherche, des travaux de recherche publiés dans des revues, des formations, etc.

- Un des fils directeurs de l'histoire de l'éthique au XXe siècle est l'émergence du respect de l'autonomie de la personne.

L'évolution du droit français, avec la **loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, sur les droits des personnes malades et la qualité du système de santé, en est un prolongement. La loi de 2002 se fonde sur le principe d'autonomie et garantit le respect de la volonté de la personne malade** :

- **La personne malade a le droit d'être informée de sa santé et des actes médicaux qu'on lui propose, d'exprimer et de faire respecter sa volonté, et donc de prendre les décisions qui concernent sa santé.**
- **Le processus de décision doit être *partagé* par le médecin et le patient.**

- Aujourd'hui, d'autres questions passent au premier plan, dont :

- La lutte contre les inégalités sociales en santé et l'accès aux soins de toutes et tous
- La lutte contre les discriminations en santé
- L'encadrement de l'usage des données de santé
- La redéfinition des relations de soin autour de l'usage de l'intelligence artificielle